Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
17ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent17vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5199836-64.2024.8.21.0001/RS

AUTOR: GRAZIELA BERTOLDO LANGARO

RÉU: UNIMED PLANALTO MEDIO/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

SENTENÇA

GRAZIELA BERTOLDO LANGARO ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, contra a **UNIMED PLANALTO MÉDIO/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA.** Relatou ser portadora de transtorno depressivo grave, com ideação suicida (CID10: F33.2), já tendo utilizado inúmeros antidepressivos e realizado abordagens terapêuticas, sem êxito. Aduziu a urgente necessidade de realizar o tratamento com o medicamento Spravato 28mg (escetamina intranasal), pois possui início de ação rápido, alta taxa de resposta e remissão em poucas semanas de tratamento, mas a requerida negou cobertura justificando ausência de previsão na Resolução 465 da ANS. Requereu a concessão de tutela de urgência determinando que a requerida forneça o medicamento Spravato® e as aplicações na clínica SINAPTA, assim como toda a assistência médica correlata necessária ao procedimento, nas dosagens, fases e continuidade do tratamento necessárias, conforme a evolução da eficácia do tratamento e, no mérito, a procedência do pedido, tornando definitivos os efeitos da tutela.

Foi deferido o parcelamento das custas (ev.9).

Foi deferida a tutela de urgência, determinando que requerida forneça, no prazo de 5 dias, a medicação prescrita para a autora, qual seja, Spravato® 28mg, devendo as aplicações serem realizadas na clínica SINAPTA (ev.15).

A requerida contestou, impugnando o valor da causa. No mérito, sustentou a licitude da negativa, argumentando que o contrato não possui cobertura para internação psiquiátrica e a medicação não possui previsão de cobertura no rol da ANS. Sustentou a ausência de comprovação científica da eficácia do medicamento solicitado, circunstância que também afasta o dever de cobertura. Requereu a retificação do valor da causa e a improcedência do pedido e, na eventual hipótese de procedência, seja determinado que a autora apresente relatório médico a cada três meses (ev.8).

Houve réplica (ev.36).

Em decisão saneadora foi rejeitada a impugnação ao valor da causa (ev.39).

As partes postularam o julgamento do processo no estado em que se encontra e foi encerrada a instrução (ev.64).

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

Julgo o processo no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, até porque as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas.

É incontroversa a relação jurídica entre as partes, aplicando-se, no ponto, o artigo 374, inciso III do CPC.

São aplicáveis ao presente caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, dentre elas a inversão do ônus da prova em favor da autora, em razão da sua hipossuficiência probatória em relação à requerida, conforme verifica-se da leitura do artigo 3º, parágrafo 2º do diploma consumerista.

Tal entendimento encontra-se consubstanciado no texto da Súmula 469 do STJ, segundo a qual, "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".*

O atestado médico emitido pelo psiquiatra Dr. Pedro Lombardi Béria, CRM/RS 38552, o qual acompanha a autora, comprova a gravidade do quadro depressivo que acomete ela, destacando que as alternativas de tratamento até então utilizadas, não alcançaram o resultado esperado, configurando um quadro de depressão resistente ao tratamento e com ideias suicidas, relatando:

Atesto, para fins de solicitação de procedimento médico, que a paciente Graziela Langaro está em tratamento psiquiátrico devido ao CID10 F33.2 (Transtorno Depressivo Recorrente Atual Episódio Grave sem Sintomas Psicóticos). Atualmente a paciente está em uso de Vortioxetina 20mg/d, Brexpiprazol 0.5mg/d e Wellbutrin 300mg/d.

Durante seu tratamento já fez uso de inúmeros antidepressivos e estratégias de potencialização, mas mesmo tendo usado todos em tempo dose adequados além de acompanhamento psicoterapeutico onde também não obteve resposta satisfatória. Conforme exposto, a paciente não respondeu a mais de 2 antidepressivos no mesmo episódio depressivo o que configura um quadro de depressão resistente ao tratamento.

Para atingirmos a remissão nesses casos podemos usar algumas estratégias como a associação de outros antidepressivos, antipsicóticos, psicoestimulantes, medicações de outras classes e psicoterapia. No caso desta paciente, todas essas alternativas supracitadas não alcançaram o resultado esperado e por isso solicito o tratamento com escetamina intranasal visando alcançar a remissão do quadro e evitar internações hospitalares.

Por essa razão, frente a gravidade do caso e pela falta de opções terapêuticas, essa solicitação visa um tratamento mais assertivo, com maior eficácia e ação rápida, para diminuir os sintomas depressivos e as ideias suicidas em uma paciente que já tentou de tudo. Atualmente, para esse tratamento, a única medicação aprovada pela Anvisa é o Spravato 28mg (escetamina intranasal - medicamento que tem como vantagem o início de ação rápido - pico em 24 horas - e alta taxa de resposta e remissão em poucas semanas de tratamento).

Contudo, a requerida negou cobertura para o medicamento justificando que o CID F33.2 (depressão recorrente) não preenche os critérios estabelecidos pela Diretriz de Utilização da ANS (ev.1, anexo7), nos seguintes termos:

FINALIZAÇÃO

O processo de junta médica que seria instaurado foi cancelado pois os auditores verificaram que o medicamento solicitado para a beneficiária não preenche os critérios para liberação. A indicação clínica para solicitação do procedimento não se enquadra na Diretriz de Utilização da ANS, conforme determina a Resolução 465 da ANS Anexo II. Cobertura obrigatória de acordo com o médico assistente, de programas de atenção e cuidados intensivos por equipe multiprofissional, inclusive administração de medicamentos, quando preenchido pelos menos um dos seguintes critérios: paciente portador de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de substância psicoativa (CID F10, F14); paciente portador de esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes (CID F20 a F29); paciente portador de transtornos do humor (episódio maníaco e transtorno bipolar do humor - CID F30, F31); paciente portador de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84).
O CID F33.2 (depressão decorrente) não preenche os critérios estabelecidos pela DUT.

A ANS aprovou, em 24/02/2021, a Resolução Normativa n° 465/2021, a qual atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, definindo os novos exames e tratamentos que passam a fazer parte da lista obrigatória dos planos de saúde.

O mencionado rol, além de estabelecer a cobertura mínima a ser observada nos planos de saúde, define a classificação dos procedimentos, bem como eventuais carências que devem ser observadas, atendendo, na integralidade, as disposições da Lei nº 9.656/98.

A RN nº 465/2021 da ANS dispõe:

Art. 2º Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde.

A Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1.886.929 e REsp 1.889.704, concluiu ser taxativa a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, não estando as operadoras do plano de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista, mas foram fixados parâmetros para, **em situações excepcionais, os planos custearem procedimentos não previstos na lista**.

Posteriormente, a Lei nº 14.454, sancionada em 21/09/2022, estabeleceu novos critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, utilizando dois parâmetros semelhantes aos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para excepcionar a taxatividade do rol, nos seguintes termos:

"Art. 10. (...)

*§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, **a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que**:*

*I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em **evidências científicas** e **plano terapêutico**; ou*

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)"

No presente caso, tanto o laudo emitido pelo médico que acompanha a autora (ev. 1, anexo 6), quanto os estudos científicos nele citados e as recentes notas técnicas favoráveis emitidas pelo NATJus/TJRS em situações semelhantes (ev.36), indicam parecer favorável ao tratamento prescrito com a medicação postulada.

Nessa senda, a requerida deve fornecer o medicamento postulado pela autora, de acordo com as prescrição médica, a ser aplicado na clínica SINAPTA.

Importante registrar que, ao contrário do que tenta fazer crer a requerida, não se está diante de hipótese de internação psiquiátrica, mas de aplicação do medicamento em ambulatorial.

Por fim, merece acolhida o pedido da requerida para que a autora apresente-lhe, a cada três meses, relatório médico, pois certamente o médico da autora fará a avaliação da eficácia e segurança do tratamento, e a requerida deve ter conhecimento da continuidade do tratamento.

PELO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora GRAZIELA BERTOLDO LANGARO contra a UNIMED PLANALTO MÉDIO/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA, tornando definitivos os efeitos da tutela de urgência deferida, devendo a requerida:

I - continuar fornecendo o medicamento Spravato 28mg, a ser administrado da seguinte forma:

INDUÇÃO:
Semana 1 a 4: 2 x por semana
- Dose no Dia 1 = 84mg (3 dispositivos de 28mg)
- Doses subsequentes = 84mg (3 dispositivos de 28mg)
MANUTENÇÃO:
Semana 5 a 8: 1 x por semana
- Doses de 84 mg (3 dispositivos de 28mg)
A partir da Semana 9 ao fim do tratamento: 1 x por semana
- Doses de 84mg (3 dispositivos de 28mg).

II - dar cobertura para as aplicações na clínica SINAPTA, assim como a assistência médica correlata necessária ao procedimento, nas dosagens, fases e continuidade do tratamento necessárias, conforme a evolução da eficácia do tratamento e,

III - determino que a autora apresente, para a requerida, a cada três meses, relatório médico acerca da continuidade do seu tratamento com a medicação em questão.

Sucumbente, arcará a requerida com o pagamento das custas processuais e com os honorários do procurador da parte contrária, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, em observância ao artigo 85, §2º do CPC/2015, corrigidos monetariamente pela variação do IGP-M a contar da data do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% a.m a contar do trânsito em julgado.

Com o trânsito em julgado, proceda-se a baixa.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CAMERIN, Juíza de Direito**, em 08/04/2025, às 14:58:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10080204361v16** e o código CRC **e06b5982**.